SENTENÇA

Processo: 0807888-89.2022.8.19.0202

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: SERGIO WILLIAM DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO SERGIO WILLIAM DE OLIVEIRA

RÉU: UNIMED RIO COOP. TRAB; MÉDICO DO RJ

Sérgio William De Oliveira propôs a Ação de Obrigação de Fazer em face de Unimed Rio Cooperativa De Trabalho Médico Ltda., nos termos da petição inicial de Id. 20841380, que veio acompanhada dos documentos de Id. 20849001/20852145.

Através da decisão no Id 21093905, foi deferida a tutela antecipada.

Citada, a parte ré apresentou sua contestação no Id. 26907337, instruída com os documentos de Id. 26908227.

Réplica apresentada no Id. 28657386.

RELATADOS. DECIDO.

Inicialmente, urge destacar que, em que pese a parte ter direito de postular pela produção das provas que entender necessárias à comprovação do alegado, cabe ao Juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de sua produção, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/2015.

A instrução probatória tem por finalidade fornecer elementos para fundamentar a convicção do juiz, sendo certo que, se verificada a existência de material suficiente nos autos a permitir a sua conclusão

sobre a pretensão autoral, é possível o indeferimento da produção de prova, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No vertente caso, diante do farto material probatório carreado aos autos, apresenta-se desnecessária a produção de outros meios de provas impondo-se, por seu turno, o julgamento antecipado da lide, na forma autorizada pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Feitas tais considerações, urge analisar a delicada situação trazida à lume.

Através da presente ação pretende a parte autora alcançar a indenização pelos danos que lhe foram causados por força de comportamento indevido perpetrado pela parte ré.

Segundo exposto na inicial, o autor é usuário do plano de saúde administrado pela empresa ré e sempre honrou com o cumprimento de suas obrigações.

Destacou ter sido diagnosticado como portador de FIBROSE PULMONAR, ensejando a perda da função pulmonar, sendo acompanhado, desde o início de seu tratamento, pelo Dr. MARCELO GERVILLA GREGÓRIO que, por sua vez, visando o controle da doença, recomendou o uso do medicamento NINTEDANIB 150 mg.
Trata-se, inclusive, de medicamento liberado pela ANVISA para tratamento de doenças pulmonares graves.

Igualmente destacado que o tratamento que o autor vinha se submetendo estava se mostrando insuficiente, razão pela qual lhe foi prescrito o uso de NINTEDANIB (OFEV), notadamente diante de sua eficácia no retardo da progressão da pneumonia intersticial fibrosante e do risco de morte caso não utilize o aludido medicamento.

Contudo, para a sua surpresa, a parte ré negou a cobertura do medicamento em questão, situação que vem lhe causando angústia e sofrimento.

A parte ré, por sua vez, asseverou a ausência de qualquer comportamento indevido, tendo, na realidade, agido respaldada no regular exercício de seu direito.

Neste momento, insta tecer certas considerações acerca da responsabilidade civil.

Analisando minuciosamente a delicada situação trazida à baila, verifica-se que a mesma representa uma nítida relação de consumo, eis que tanto a parte autora, como a parte ré se caracterizam, respectivamente, como consumidora e fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º, parágrafos 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor, *in verbis*:

> "**Art. 2º**: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
>
> "**Art. 3º**: (...) **Parágrafo primeiro** –Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. **Parágrafo segundo** - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Assim, diante da relação jurídica firmada entre as partes, pode-se afirmar que o réu colocou os seus serviços à disposição da Sociedade, razão pelo qual não pode se colocar à margem do Direito do Consumidor, aplicando-se, em sua plenitude, os ditames de ordem pública consagrados no referido diploma legal.

Igualmente importante destacar o teor da Súmula 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

> "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Outra observação a ser efetuada é que se sobressai o fato de que os serviços da parte ré estão no mercado de consumo, encontrando-se regido pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos que tais serviços possam ter causado, nos termos do artigo 6º, VI, do referido diploma legal, *in verbis*:

> "**Art. 6º**. São direitos básicos do consumidor: (...) **VI** - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Também não se pode deixar de mencionar que se aplica à parte ré a Teoria do Risco do Empreendimento. Assim, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência da culpa.

Segundo expõe o ilustre Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra "Programa de Responsabilidade Civil", 1ª Edição – 2ª Tiragem, Malheiros Editores, "(...) este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de (...) executar determinados serviços" (p. 318).

Por derradeiro, a parte ré, na qualidade de prestadora de serviços, se obriga a prestá-los de forma adequada e eficiente, de sorte a não causar nenhum tipo de dano ao consumidor, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados ao mesmo.

Ainda incidem os ditames do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, impondo à parte ré a responsabilidade de natureza objetiva, onde não se discute a culpa.

Por via de consequência, a sua responsabilidade somente pode ser afastada diante de hipóteses que excluam o nexo causal, hipóteses estas que se encontram disciplinadas no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal citado.

Desta forma, para que surja tal responsabilidade da parte ré, basta que se demonstre, de forma cabal e induvidosa, a existência do dano, bem como o nexo causal.

O primeiro elemento acima identificado, qual seja, o dano, pode ser conceituado como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial ou integrante da própria personalidade da vítima. Sem tal elemento não há de se falar em indenização ou ressarcimento. Daí se conclui que o dano é o elemento preponderante da responsabilidade civil.

O último elemento, também importante para gerar a responsabilidade civil, é o nexo causal, vale dizer, a relação de causa e efeito entre o comportamento culposo e o dano. Assim, chega-se à inarredável conclusão de que o dano deve ser consequência direta e imediata do ato culposo que lhe deu causa.

O intuito do legislador, ao consagrar a responsabilidade objetiva se deu diante da notória hipossuficiência do consumidor, parte mais fraca na relação de consumo e diante do fato de que, dentre seus direitos fundamentais, consagrados no Código Protetivo, se encontra o de facilitar o seu acesso aos meios de defesa.

Voltando ao caso concreto, restou incontroverso que o autor, lamentavelmente, foi diagnosticado como portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, tratando-se de uma moléstia progressiva e capaz de evoluir a óbito caso não tratada (ID 20849035).

Igualmente constatada a necessidade do uso de medicamento antifibrótico com o intuito de impedir a progressão da doença (ID 20849035).

Conforme destacado pela médica responsável pelo seu tratamento, Dra. MARIANA C. LOPES, "(...) os pacientes que utilizam essa medicação podem reduzir a progressão da doença, dobrando a expectativa de vida e reduzindo a possibilidade de exacerbações relacionadas à fibrose. O risco de morte é muito alto quando ocorre a exacerbação. É fundamental que o medicamento seja iniciado o quanto antes para inibir a progressão da doença respiratória. Assim, solicitamos o NINTEDANIB (OFEV) 150 mg, que deve ser usado de forma contínua, nas refeições, duas vezes ao dia, pelo resto da vida do paciente (...)" (ID 20849035).

Porém, não obstante atestada a necessidade do uso do aludido medicamento, a parte ré se recusou a fornecê-lo sob o fundamento de que se trata de uso ambulatorial e, portanto, excluído de cobertura contratual (ID 20852145).

Realmente, analisando a documentação que instruiu a inicial, verifica-se que a parte ré não incorreu em falha na prestação de seus serviços, mostrando-se, por conseguinte, legítima a recusa no fornecimento do medicamento em questão.

Não se pode olvidar do disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9656/98, *in verbis*:

> "**Artigo 10**: É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médica-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 desta Lei, exceto: (...) **VI** – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c', do inciso I, e 'g', do inciso II, do artigo 12".

A ressalva prevista no artigo 12, alíneas “c”, do inciso I e “g” do inciso II, é a seguinte:

> “**Art. 12**. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: **I** - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) **c)** cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) **II** - quando incluir internação hospitalar: (...) **g)** cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”.

Daí se depreende que as regras contidas na Lei nº 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) são absolutamente claras no sentido de que o custeio e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estão contemplados dentre as coberturas obrigatórias para os planos de assistência à saúde, exceto os antineoplásicos domiciliar de uso oral, o que não é o caso destes autos.

Ao mesmo tempo, o 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021, assim dispõe:

> “**Art. 17**. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. **Parágrafo único**. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) **VI** - fornecimento de medicamentos para

> tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13".

Ao derradeiro, não se vislumbra nenhuma irregularidade ou abusividade no comportamento perpetrado pela parte ré que, na verdade, nada mais fez do que cumprir as condições estabelecidas no contrato firmado e as disposições legalmente estabelecidas pelo legislador pátrio.

Inclusive, conforme bem observado pelo ilustre respeitado Desembargador MARCOS ANTÔNIO IBRAHIM, quando do julgamento do Agravo de Instrumento número 0063515-38.2022.8.19.0000, que tramitou perante a Vigésima Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, "(...) de acordo com a Resolução Normativa número 465/21 da ANS, 'medicamentos para tratamento domiciliar' são 'aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde'. Em consulta à bula do medicamento NINTEDANIB (OFEV) 150 mg, verifica-se que o uso é oral, mediante simples ingestão do comprimido, sendo, portanto, de uso domiciliar regular. (...) Considerando, portanto, que o medicamento é de uso domiciliar, não há como afastar o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. Cumpre ressaltar que a ampliação da cobertura prevista no contrato e na legislação em vigor, sem a devida contraprestação financeira por parte dos mutuários, causa desequilíbrio contratual e prejudica a segurança jurídica, sendo certo que, no presente caso, não há qualquer alegação autoral no sentido de que exista a referida cobertura contratual. A tese do demandante se baseia apenas no suposto dever de fornecimento em razão do caráter emergencial do tratamento (...)" (ID 181212047).

Neste mesmo sentido vale a pena trazer à lume os seguintes julgados:

> "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIPAMAENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE E MEDICAMENTO DE USO

DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, observa-se que a Corte local decidiu em desacordo com o entendimento firmado por ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 1.1. Hipótese em que são pleiteados insulina e equipamento para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.126.278/MS, Terceira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA. AÇÃO OBJETIVANDO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1, COM A UTILIZAÇÃO DE DOIS TIPOS DE INSULINA, INSUMOS E SENSOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE) PARA CONTROLE

DOS NÍVEIS DE GLICOSE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO DE USO DOMICILIAR, NÃO SE TRATANDO DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA E HOME CARE. MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTO DE USO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. DESCABÍVEL, NA HIPÓTESE, COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJRJ. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO" (TJRJ, Apelação Cível nº 0872103- 95.2022.8.19.0001, Décima Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES).

Assim, conforme destacado linhas atrás, afigura-se legítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde, inexistindo, por conseguinte, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Neste diapasão, impõe-se o completo afastamento da pretensão autoral eis que divorciada da realidade fática.

Isto posto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora, como decorrência de sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais, devidas por força de lei, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, tendo em vista que o autor se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade de tal ônus.

P.R.I.

RIO DE JANEIRO, 6 de maio de 2025.

FLAVIA GONCALVES MORAES BRUNO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: FLAVIA GONCALVES MORAES BRUNO
06/05/2025 14:53:37
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25050614533647600000180628250

IMPRIMIR GERAR PDF